

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TRAIT META-MOOD SCALE-24 (TMMS-24)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Inteligencia Emocional Percibida y Metaconocimiento Afectivo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).
Nombre Original (Inglés)	<i>Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24)</i>
Autores Originales	Drs. Peter Salovey, John D. Mayer, S. L. Goldman, C. Turvey y T. P. Palfai (1995), Yale University.
Adaptación Española	Pablo Fernández-Berrocal, Natalio Extremera y Natalia Ramos (2004), Universidad de Málaga.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo de Inteligencia Emocional Percibida (Salovey & Mayer).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 24 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Aplicable en psicología clínica, educativa y organizacional.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración; 7 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto de libre distribución para uso clínico e investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y METACONOCIMIENTO AFECTIVO

La TMMS-24 es la herramienta psicométrica por excelencia fundamentada en el modelo de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer. En lugar de evaluar la ejecución o el rendimiento máximo de habilidades en laboratorio, evalúa la **Inteligencia Emocional Percibida (IEP)**: la creencia metaconocitiva y la autoevaluación subjetiva que el individuo hace sobre su capacidad para atender, discriminar y regular sus estados de ánimo en la vida real.

A nivel neurobiológico, la IEP refleja la coordinación recíproca entre las áreas corticales superiores de integración asociativa (córtex prefrontal ventromedial y dorsolateral) y los centros de procesamiento interoceptivo y visceral (córtex insular y cíngulo anterior). Un perfil armónico exige un balance preciso: atender a las emociones sin caer en la hipervigilancia rumiativa, comprender con claridad su génesis y poseer estrategias neuroejecutivas consolidadas para interrumpir bucles de afecto negativo y reparar el estado anímico.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión de la IEP	Ítems (8 c/u)	Rango Dir.	Definición Operativa del Proceso Metacognitivo
1. Atención Emocional	1 al 8 (8 ítems)	8 a 40	Grado en que la persona presta atención y reflexiona sobre sus propios sentimientos y estados anímicos.
2. Claridad de Sentimientos	9 al 16 (8 ítems)	8 a 40	Comprensión adecuada de lo que siente; capacidad para etiquetar, diferenciar y entender sus emociones.
3. Reparación Emocional	17 al 24 (8 ítems)	8 a 40	Capacidad subjetiva para frenar emociones displacenteras y potenciar o mantener estados afectivos positivos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en España: alfa de Cronbach de 0.90 para Atención, 0.90 para Claridad y 0.86 para Reparación (Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). Coeficientes test-retest $r = 0.81$ a 0.85 a las 4 semanas.
Estructura Trifactorial	El AFC demuestra un ajuste óptimo del modelo de tres factores correlacionados ($CFI = 0.96$, $RMSEA = 0.049$), confirmando la reducción limpia de los 48 ítems originales a los 24 reactivos esenciales.
Validez Concurrente y Predictiva	Claridad y Reparación correlacionan directamente con satisfacción vital (SWLS, $r = 0.45$) y bienestar, e inversamente con depresión (BDI-II, $r = -0.42$). Atención elevada correlaciona con rumiación y neuroticismo.
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones de educación emocional, programas de liderazgo y protocolos de inteligencia emocional basada en habilidades (Mayer-Salovey-Caruso).
Invarianza por Sexo	Estructura invariante entre varones y mujeres, fundamentando la necesidad de puntos de corte normativos diferenciados por sexo debido a diferencias biológicas y de socialización.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los reactivos se responde de 1 a 5 (1 = «Nada de acuerdo», 2 = «Algo de acuerdo», 3 = «Bastante de acuerdo», 4 = «Muy de acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo»). No contiene reactivos invertidos.

- **Atención Emocional:** Suma de los ítems **1 al 8** (Rango: **8 a 40 puntos**).
- **Claridad Emocional:** Suma de los ítems **9 al 16** (Rango: **8 a 40 puntos**).
- **Reparación Emocional:** Suma de los ítems **17 al 24** (Rango: **8 a 40 puntos**).
- **Regla Esencial:** No debe calcularse una puntuación total sumada. El valor interpretativo reside exclusivamente en el perfil integrado de las tres subescalas analizadas según el sexo biológico.

6. BAREMOS NORMATIVOS Y PUNTOS DE CORTE EN ESPAÑA (Fernández-Berrocal et al., 2004)

Dimensión	Población	Puntuación Directa	Interpretación Clínica / Normativa
Atención Emocional	Hombres Mujeres	≤ 21	Debe prestar más atención
		≤ 24	Debe prestar más atención
		22–32	Adecuada atención
		25–35	Adecuada atención
		≥ 33 ≥ 36	Demasiada atención (Riesgo hipervigilancia)
Claridad Emocional	Hombres Mujeres	≤ 25	Debe mejorar su claridad (Confusión afectiva)
		≤ 23	Debe mejorar su claridad
		26–35	Adecuada claridad emocional
		24–34	Adecuada claridad emocional
		≥ 36 ≥ 35	Excelente claridad emocional
Reparación Emocional	Hombres Mujeres	≤ 23	Debe mejorar su reparación (Bloqueo regulatorio)
		≤ 23	Debe mejorar su reparación
		24–35	Adecuada capacidad de reparación
		24–34	Adecuada capacidad de reparación
		≥ 36 ≥ 35	Excelente capacidad de reparación

EL PERFIL DISFUNCIONAL CLÁSICO (ALTA ATENCIÓN + BAJA CLARIDAD):

El patrón clínico de máximo sufrimiento afectivo es la combinación de **Demasiada Atención ($\geq 33/36$)** con **Baja Claridad ($\leq 25/23$)** y **Baja Reparación (≤ 23)**. El paciente atiende de forma obsesiva e ininterrumpida a sus estados anímicos pero no comprende lo que le ocurre ni posee habilidades para autorregularse, quedando atrapado en una espiral de rumiación y angustia.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

GUÍA DE INTERVENCIÓN SECUENCIAL SEGÚN EL PERFIL TMMS-24:

- **Paso 1: Si hay “Demasiada Atención” (> 33/36):** Prohibir el auto-monitoreo afectivo constante. Entrenar técnicas de focalización externa de la atención (ATT de Wells) y mindfulness de absorción exterior para frenar el escaneo somatosensorial.
- **Paso 2: Si hay “Baja Claridad” (< 24):** Entrenamiento intensivo en etiquetado afectivo y diferenciación semántica emocional (desmontar el genérico “estoy mal” en ira, desilusión, tristeza o culpa mediante el modelo de Russell).
- **Paso 3: Si hay “Baja Reparación” (< 24):** Entrenamiento en reestructuración cognitiva, búsqueda activa de reencuadre positivo y conductas placenteras estructuradas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD Y RUMIACIÓN AFECTIVA

Paciente: Mujer de 26 años, enfermera de UCI, acude a consulta médica por agotamiento mental y crisis de ansiedad matinales. Refiere que analiza constantemente todo lo que siente a lo largo de su turno laboral: «Me paso el día preguntándome por qué tengo este nudo en la garganta o qué significa lo que siento».

Evaluación Cuantitativa Inicial TMMS-24:

- **Atención Emocional: 38 / 40 puntos** (Demasiada atención; percentil 95 femenino). Hipervigilancia masiva.
- **Claridad Emocional: 18 / 40 puntos** (Debe mejorar; confusión emocional severa).
- **Reparación Emocional: 16 / 40 puntos** (Debe mejorar; sensación de incapacidad absoluta para calmarse).

Formulación Clínica: Trampa de hiperfoco afectivo sin capacidad de resolución. La paciente cree erróneamente que “analizar cada sensación” la protegerá, cuando en realidad alimenta una rumiación que desborda sus recursos ejecutivos.

Tratamiento y Evolución: En 10 sesiones se redujo el tiempo de autoinspección limitándolo a un registro de 5 minutos al día, mientras se entrenó rotulación afectiva precisa y técnicas de defusión. A los 3 meses: Atención = **28** (Adecuada), Claridad = **32** (Adecuada) y Reparación = **33** (Adecuada), con normalización de la jornada laboral.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TRAMPA TERAPÉUTICA DE LA ATENCIÓN EXCESIVA

En pacientes con TMMS-24 con Atención > 35, prescribir diarios de registro emocional exhaustivo o introspección profunda resulta contraproducente e iatrogénico. La prioridad es desviar el foco hacia el exterior y la acción comprometida.

INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA POR SEXO

Aplicar siempre los baremos específicos para varones o mujeres. Emplear un baremo unificado induce falsos positivos de “demasiada atención” en mujeres y falsos negativos de “déficit de claridad” en varones.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, & health* (pp. 125–154). American Psychological Association.
2. Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. *Psychological Reports*, 94(3), 751–755.
3. Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the Trait Meta-Mood Scale. *Personality and Individual Differences*, 39(5), 937–948.
4. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence* (pp. 3–31). Basic Books.